



Nome

ISNALDO SANTOS SOBRINHO

Data de Nascimento

23/07/1958 (67 anos)

1 / 5

Solicitante

GERALDO FELICIO DA CUNHA JUNIOR - CRM-MG 33221

Data Entrada

28/08/2025 9457805-AIM

Pedido

Laudo em outro identificador.

Liberado: 03/09/2025

Resultado Impresso por paciente (%BFFAPPCIENTE). Data Impressão: 04/09/25 08:14

Thiago Carvalho Pires
CRM-MG 80653 RQE 57508

Luciana Costa Silva
CRM-MG 28151 RQE 19315

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: 744ec975b8ffcad67537e2313afb6934b6035bf198c246ac043467460b4f9e8a

Este é um exame baseado em imagens cuja finalidade é auxiliar o médico em seu diagnóstico. Existem limitações inerentes ao método, por isso, o resultado deve ser confrontado com os dados clínicos e com outros exames de imagem e/ou laboratoriais, prévios e subsequentes. Portanto, nem sempre pode ser considerado conclusivo. Somente seu médico tem condição de interpretar corretamente este relatório.



Nome

ISNALDO SANTOS SOBRINHO

Data de Nascimento

23/07/1958 (67 anos)

2 / 5

Solicitante

GERALDO FELICIO DA CUNHA JUNIOR - CRM-MG 33221

Data Entrada

28/08/2025 9457805-AIM

Pedido

EXAME DOCUMENTADO EM 10 FILICOATS.**RELATÓRIO****RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME E PELVE
COM LAUDO EVOLUTIVO****HISTÓRIA CLÍNICA:**

Controle pós-radioablação hepática - Ca de cólon. Paciente relata última radioablação hepática em 05/2025.

TÉCNICA DE EXAME:

Pré-contraste:

Sequências multiplanares *fast spin-echo* ponderadas em T2.

Sequências axiais *gradient-echo* ponderadas em T1 *in-phase* e *out-of-phase*.

Sequências axiais ponderadas em T1 com supressão de gordura.

Sequências EPI ponderadas em difusão com valores de b de 0, 50, 150 e 1000.

Pós-contraste:

Estudo dinâmico através de sequências axiais e coronal ponderadas em T1 com supressão de gordura, sendo feitas as fases arterial, venosa portal e de equilíbrio.

COMPARAÇÃO:

Realizado estudo comparativo com exames prévios, o último datado de 19/04/2025 (RM do abdome e pelve).

AValiação ONCOLÓGICA:

Surgimento de áreas ovaladas de alteração de sinal sugestivas de necrose coagulativa em topografia dos dois nódulos hepáticos visibilizadas no estudo prévio, caracterizadas por hipersinal heterogêneo em T1, sem realce evidente pelo meio de contraste no estudo atual, localizadas nos segmentos III e VIII, medindo 30,0 mm e 42,0 mm, respectivamente.

Destaca-se discreta área linear subcapsular de hiper-realce arterial pelo meio de contraste no segmento VIII, superiormente, sem sinais de restrição à difusão, sugestiva de distúrbio perfusional.

Permanecem de aspecto semelhante às outras áreas de necrose coagulativa localizadas no aspecto cranial do segmento II e inferior do segmento III do fígado, sem evidências de realce pelo meio de contraste ou restrição à difusão, medindo 32,0 mm e 35,0 mm, respectivamente.

Ausência de líquido livre, massas ou coleções na cavidade abdominal e pélvica.

Não identificamos linfonodomegalias nas cadeias analisadas.

DEMAIS ASPECTOS OBSERVADOS:

Fígado de dimensões usuais, apresentando forma anatômica, contornos regulares e lisos. Notam-se pequenas formações císticas esparsas, sem realce pelo meio de contraste, medindo até 4,0 mm. Restante do parênquima homogêneo, apresentando fração da intensidade de sinal de gordura estimada



Nome

ISNALDO SANTOS SOBRINHO

Data de Nascimento

23/07/1958 (67 anos)

3/5

Solicitante

GERALDO FELICIO DA CUNHA JUNIOR - CRM-MG 33221

Data Entrada

28/08/2025 9457805-AIM

Pedido

7,0%, indicando esteatose em grau leve.

Veias hepáticas e veia porta visibilizadas, com aspecto anatômico.

Ausência de dilatação de vias biliares intra ou extra-hepáticas.

Vesícula biliar visibilizada em sua topografia habitual, apresentando características usuais.

Baço não identificado. Presença de estrutura nodular localizada em sua topografia, adjacente à cauda do pâncreas, medindo 29,0 mm, sugestiva de baço acessório/esplenose.

Pâncreas de dimensões e intensidade de sinal usuais. Não há evidências de dilatações do ducto pancreático principal ou de coleções peripancreáticas.

Adrenais anatômicas, sem evidências de lesões focais.

Rins eutópicos, apresentando volume, forma e contornos usuais, com o parênquima de espessura preservada. Identificam-se algumas pequenas estruturas císticas de contornos regulares e bem definidos, sem realce pelo meio de contraste, esparsas bilateralmente, medindo até 5,0 mm (Bosniak I). Não há evidências de dilatação do sistema pielocalicinal. Espaços perirrenais anatômicos.

Bexiga com forma, contornos e conteúdo normais.

Aorta abdominal e veia cava inferior de trajeto e calibres normais.

Próstata com volume levemente aumentado e com sinais de ressecção transuretral. Vesículas seminais de aspecto habitual.

IMPRESSÃO: * Ressonância magnética de abdome e pelve revelando:

Surgimento de áreas de alteração de sinal sugestivas de necrose coagulativa nas lesões hepáticas anteriormente visibilizadas no segmentos III e VIII, sem evidências de resíduo tumoral detectável ao método.

Estabilidade das áreas de necrose coagulativa nos segmentos II e III do fígado, sem evidências de recidiva tumoral.

Restante do estudo sem alterações de relevância oncológica detectáveis pelo presente método de imagem.

tcp/lcs

Instituto Hermes Pardini - Unidade Aimorés

Núcleo Especializado em Imagem em Oncologia

Coordenação Médica: Dra. Luciana Costa Silva - C R M - M G: 28151



Thiago Carvalho Pires
CRM-MG 80653 RQE 57508



Luciana Costa Silva
CRM-MG 28151 RQE 19315

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: 628dc2bdd1fdd8ee4724b1e16c7f1ed23566cb1c8f984700760508c4ee9170dd



Nome

ISNALDO SANTOS SOBRINHO

Data de Nascimento

23/07/1958 (67 anos)

4 / 5

Solicitante

GERALDO FELICIO DA CUNHA JUNIOR - CRM-MG 33221

Data Entrada

28/08/2025 9457805-AIM

Pedido

EXAME DOCUMENTADO EM: 03 FILICOATS (01) ***RELATÓRIO****TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE DO TORAX
COM LAUDO COMPARATIVO****INDICAÇÃO CLÍNICA:**

CID C18.

ASPECTOS TÉCNICOS:

Realizada aquisição volumétrica em tomógrafo multislice sem a infusão endovenosa do meio de contraste. Posteriormente foram realizadas reconstruções multiplanares.

COMPARAÇÃO:

Realizado estudo comparativo com exames prévios, o último datado de 23/04/2025 (TC de tórax).

ASPECTOS OBSERVADOS:

Permanecem estáveis os pequenos nódulos pulmonares sólidos esparsos bilateralmente, predominantemente com formato poliédrico e pericissurais, medindo até 7,0 mm no estudo atual, em comparação a 7,0 mm nos estudos prévios, de aspecto benigno, sugestivos de linfonodos intrapulmonares.

Presença de discretos focos de enfisema centrolobular e parasseptal bilateralmente, predominando nos campos superiores.

O restante do parênquima pulmonar apresenta densidade tomográfica usual, com distribuição vascular de aspecto anatômico. Não há evidências de consolidações, massas ou nódulos pulmonares suspeitos.

Traqueia e brônquios principais pervingos, de dimensões e paredes normais.

Mediastino de configuração anatômica.

Não há evidências de linfonodomegalias.

Vasos mediastinais de curso e calibre normais.

Coração de tamanho normal, sem sinais de aumento de suas cavidades.

Superfícies e cavidades pleurais sem sinais de derrame ou pneumotórax.

Alterações degenerativas discretas na coluna torácica.

Estrutura óssea sem evidências de lesões suspeitas detectáveis.



Nome

ISNALDO SANTOS SOBRINHO

Data de Nascimento

5 / 5

23/07/1958 (67 anos)

Solicitante

GERALDO FELICIO DA CUNHA JUNIOR - CRM-MG 33221

Data Entrada

Pedido

28/08/2025 9457805-AIM

IMPRESSÃO: Estudo por tomografia computadorizada multislice do tórax evidenciando:

Ausência de alterações de relevância oncológica detectáveis pelo presente método de imagem.
tcp/lcs

Instituto Hermes Pardini - Unidade Aimorés
Núcleo Especializado em Imagem em Oncologia
Coordenação Médica: Dra. Luciana Costa Silva C R M - M G: 28151

* Exame disponível pela internet.



Thiago Carvalho Pires
CRM-MG 80653 RQE 57508



Luciana Costa Silva
CRM-MG 28151 RQE 19315

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: 78171db6343bfa9c95487a089c1cdc8d81c8a992a3e9fa47b8cca1ad4bd43410

Este é um exame baseado em imagens cuja finalidade é auxiliar o médico em seu diagnóstico. Existem limitações inerentes ao método, por isso, o resultado deve ser confrontado com os dados clínicos e com outros exames de imagem e/ou laboratoriais, prévios e subsequentes. Portanto, nem sempre pode ser considerado conclusivo. Somente seu médico tem condição de interpretar corretamente este relatório.